Organisation des urgences, jour et nuit

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Qui appelle qui, avec quels moyens, et comment le tracer : chaîne d'appel, page établissement, fiche d'appel de nuit, retour d'expérience.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME — médecin coordonnateur / médecin d'établissement, direction, IDEC

À RETENIR

Urgence vitale (niveau 1 de la Fiche 0) : le premier témoin appelle le 15, sans chercher l'IDE ni le cadre. Hors urgence vitale : AS / AES / éducateur → IDE sur place ou d'astreinte → médecin joignable → 15. DOTR n'est pas un service d'urgence.

Sources : ASSURE Île-de-France, fiches A et D (2023) · ARS IDF/SGGIF, fiche 0 (2016) · ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, fiche 0 (2023)

LA CHAÎNE D'APPEL (LOGIGRAMME)

- ① **Niveau 1 de la Fiche 0** (ne répond pas, respire mal, convulsion > 5 min, douleur thoracique, signes d'AVC…) → **15 par le premier témoin** ; RCP + DSA si besoin ; puis IDE et cadre d'astreinte.
- ② **Niveau 2** (pouls < 50 ou > 120, PAS < 100 ou > 200, SpO2 < 90 %…) → **IDE sans délai** ; IDE non joignable immédiatement → **15**.
- ③ **IDE** → évalue, applique le protocole signé s'il existe (R4311-6 2° ou R4311-7), puis **médecin présent ou joignable** : médecin traitant, médecin coordonnateur / d'établissement, **DOTR aux heures ouvrées via HEALPHI**.
- ④ **Aucun médecin joignable** dans un délai compatible avec l'état de la personne → **15**.
- ⑤ **Niveau 3** (signaler dans l'heure) → IDE ; avis médical différé possible (DOTR, médecin traitant), tracé.

Sources : ARS IDF/SGGIF, fiche 0 (2016) · ASSURE IDF, fiche A (2023) · EHPUR, Urg'ARA/ARS ARA (2019, MAJ 07/2025) · Fiche 0 de la collection DOTR

NUIT AVEC IDE (SUR PLACE OU D'ASTREINTE)

- IDE d'astreinte : **conseil téléphonique et déplacement** selon le cahier des charges ARS ; les urgences vitales ne relèvent pas de l'IDE de nuit : « l'appel au SAMU doit rester la règle ».
- L'IDE agit sur **prescription écrite**, **prescription anticipée** (R4311-6 2°) ou **protocole d'urgence** (R4311-7, compte rendu écrit, daté, signé).
- Consigne téléphonique d'un médecin (15, astreinte, DOTR) → **télé-prescription écrite** : R4311-6 ne prévoit plus « sauf urgence ».
- Aucune obligation réglementaire d'IDE de nuit en EHPAD trouvée ; astreintes financées par les ARS (appels à candidatures).

Sources : CSP R4311-6 et R4311-7 (décret n° 2025-1306 du 24/12/2025) · ARS Bretagne, cahier des charges astreinte IDE de nuit (11/2018) · instruction DGCS/DSS/CNSA n° 2022/108 du 12/04/2022

NUIT SANS IDE (AS, AES, ÉDUCATEURS SEULS)

- Chacun reste dans son périmètre : **pas d'injection**, pas de mise en route de l'O2, pas de « si besoin » sans validation de l'IDE ou du médecin (protocole DOTR « si besoin »).
- Exception : traitement **prédosé** prévu par un protocole individuel / PAI (midazolam buccal, adrénaline auto-injectable).
- Niveau 2 sans IDE joignable → **15 directement**, en disant qui est présent (« AS seule, pas d'IDE ») : le régulateur doit en tenir compte.
- Le **cadre d'astreinte non soignant** gère la logistique, **jamais** une décision thérapeutique.

Sources : Arrêté du 26/06/2026 (actes), art. 2 · CASF L313-26 · OMéDIT Centre-Val de Loire, urgences en EHPAD (02/2025) · CAA Lyon (commentée 02/2026, ACCENS/FNASFO)

LE RÔLE DE DOTR ET DU MÉDECIN COORDONNATEUR

- **DOTR** : téléconsultation et avis aux heures ouvrées ; photos, vidéos, pièces jointes par **HEALPHI** ; traite le non-urgent et le différé (« à montrer au médecin le matin ») ; ne remplace ni le 15 ni la permanence des soins.
- **Médecin coordonnateur d'EHPAD** : prescrit en cas d'urgence ou de risques vitaux, ou si le médecin traitant n'est pas en mesure d'intervenir (consultation, conseil téléphonique, téléprescription) ; médecin traitant **toujours informé** ; signale à la direction les difficultés de permanence des soins.
- **MAS / FAM / EAM** : coordination des soins sous la responsabilité d'un médecin ; **convention de transfert** avec un établissement de santé. **Polyhandicap** : convention avec un établissement disposant d'une réanimation.

Sources : CASF D312-158 I 3° et 12° (décret n° 2025-897 du 04/09/2025) · CASF D344-5-5 5°, D344-5-6 2° · CASF D312-88 · CASF D312-155-0 I 5° (conventions EHPAD) · proposition DOTR (périmètre DOTR)

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

PAGE ÉTABLISSEMENT — QUI APPELER

Présents la nuit (fonctions, nombre) : .....

IDE de nuit sur place : oui / non — horaires : .....

IDE d'astreinte : n° et horaires : .....

Médecin d'astreinte / de garde : n° : .....

Médecin coordonnateur / d'établissement : n° : .....

Cadre d'astreinte (logistique) : n° : .....

DOTR : jours et horaires : .....

DOTR : canal HEALPHI / n° de contact : .....

Sources : OMéDIT CVL, affiche « CAT en cas d'urgence » à compléter (02/2025) · ARS Bretagne (2018), fiche établissement

PAGE ÉTABLISSEMENT — OÙ, COMMENT

Codes d'accès (portes, logiciel) : où ? : .....

Chariot / sac d'urgence (scellé) : .....

DSA : .....

Oxygène, aspiration : .....

Dotation urgente : qui a la clé ? : .....

DLU et dossiers (nuit) : .....

Pharmacie de garde : .....

Hôpital de référence (convention) : .....

EMSP / HAD / équipe mobile gériatrique : .....

Sources : ARS Bretagne (2018) · OMéDIT IDF/ARS IDF, dotations en EHPAD (09/2025) · proposition DOTR

FICHE D'APPEL DE NUIT (UNE PAR APPEL)

- ☐ Date, heure, résident, appelant (fonction), **niveau Fiche 0** (1, 2 ou 3), fiche de la collection utilisée
- ☐ Paramètres relevés (pouls, PA aux deux bras, FR, SpO2, T°, glycémie si AS/AP), heure
- ☐ Qui a été appelé, à quelle heure, **délai de réponse** ; consigne reçue ; télé-prescription écrite reçue : oui / non
- ☐ Issue : maintien sur place, transfert, intervention du SMUR ; heure de fin
- ☐ Relue et **contresignée par l'IDE** le matin ; transmise au médecin (traitant, coordonnateur, DOTR)

Indicateurs (proposition DOTR)

Nombre d'appels par mois, motifs, délais de réponse, appels au 15, transferts, hospitalisations évitées : à revoir lors de la journée trimestrielle sur site DOTR.

Sources : ARS PACA, appel à candidatures IDE de nuit (03/2019) · ARS Occitanie, IDE de nuit mutualisé (06/2019) · proposition DOTR

FORMATION ET RETOUR D'EXPÉRIENCE

- **Fiche 0** et message au 15 (SAED) : formation de tous, **personnel de nuit, remplaçants et intérimaires compris**, à la prise de poste puis périodiquement.
- AFGSU à jour selon la fonction ; démonstration du chariot / sac d'urgence et du DSA.
- Exercice simulé (un cas) lors de la journée trimestrielle sur site DOTR (proposition DOTR).
- **REX après chaque appel au 15** : chronologie, délais, ce qui a aidé ou manqué ; FEI si dysfonctionnement ; EIGS si les critères sont réunis (fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »).

Sources : ARS IDF/SGGIF (2016) : formation « souhaitable » au moins sur la fiche 0 · ASSURE IDF (2023) · arrêté du 30/12/2014 modifié (AFGSU) · CSP L1413-14 · proposition DOTR

MESSAGE AU 15

SAED : Situation – Antécédents – Évaluation – Demande. Toujours : glycémie, PA aux deux bras, anticoagulant ou antiagrégant, LAT / directives anticipées / niveau de soins, numéro de rappel. La nuit : faire ouvrir la porte. **Ne pas raccrocher sans l'accord du régulateur.** DLU prêt (fiche socle « DLU et transfert aux urgences »).

Sources : HAS, SAED (2014), repris par ASSURE IDF fiche C · EHPUR ARA, check-list avant appel · OMéDIT CVL (02/2025)

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.